



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رباب مصطفى محمد عبد المعطي

العنوان : ممم

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

رقم البطاقة : 28109260102823 رقم التليفون : 01148040076

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-09-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: رباب مصطفى محمد عبد المعطل
National ID: 28109260102823



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ ومساءة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ ومساءة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



رياب

مصطفى محمد عبد المصطفى

مجنورة ٢ - عنابة

خمسة عشر مايو - القاهرة

٢٨١٠٩٢٦٠١٠٢٨٢٣

KY1281002

١٠٩٩٩١٧٧٧٦

٢٠٢٤

٢٠٢٤



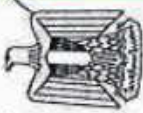
٢٠٢٤/١٢ - ٢٨١٠٩٢٦٠١٠٢٨٢٣

حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق

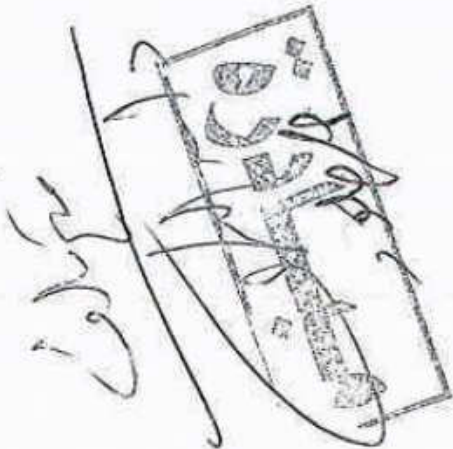
أنثى

مسلم

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٢/٣٠



ERM036748507



04/20/2026

MDT FORM

Name:	Rabab Mostafa Mohamed Abd Elmoaty	MRN:	2234
Age:	45 Y	ID:	28109260102823
Menopausal Sta	pre	Phone:	01148040076
NRS SCORE:	3	Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	

Clinical Data:
 BX: R L
 ER: PR: HER2: KI67:
Sonomammography:**Mets Workup:****History:**

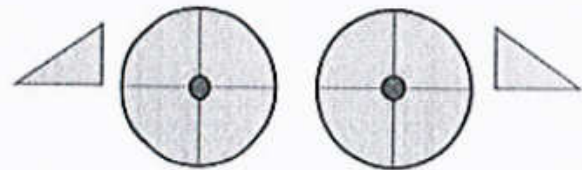
prem left breast cancer met to bone ldc 2 er8/8 pr8/8 her2-ve rec zoladex al
 from 11/2025 after 3 m dp locally rebopsy triple nnegative rec 14 weeks taxol
 bs sd sm dp with dp locally nwewly developed skin nodules left breast and
 axilla for mdt

Recommendations:

for xeloda

MDT Outcome & Plan

XELODA NAVELBINE

**T N M****SIGNATURE**

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ الزين مصطفى					

Name: رباب مصطفى محمد عبد المعطي		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 2234			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
27-1-2026 Clinical Pharmacy Visit: W5 Taxol 140mg Clinical Pharmacy: W6 Taxol 140mg Next Visit --> Clinic a case of MBC to bone on weekly taxol + zometa q 3 m missing MDT for new labs + week 7 Taxol 160 mg zometa due on 31/3 BRCA TESTING = NO MUTATION DETECTED Pt received 5 sessions palliative RTH to left shoulder, hip and thigh in 11/2025 week 8, 9 pharmacy a case of MBC to bone on weekly taxol 160 mg week 9 , , BRCA TESTING = NO MUTATION DETECTED Pt received 5 sessions palliative RTH to left shoulder, hip and thigh in 11/2025 week 10 pharmacy (with labs) , week 11 pharmacy waiting CTS , to assess surgical planning MBC TO BONE (NEW EVULATION PENDING) FOR TAXWOLW12 (W13--ZOETA /ZOLADEX ---+W15 +W16 IN PH) Clinical Pharmacy Intervention: CBC (19/3/2026): Hgb: 7.8 For New CBC before this week New CBC (24/3/2026) Hgb: 8.6 to proceed W 12 Taxol 160 mg Clinical Pharamcy Visit: W13 Taxol 150 mg + Zometa Pharmacy Note For Zoladex 10.8 today Last Zoladex 6/1/2026 prem left breast cancer met to bone idc 2 er8/8 pr8/8 her2-ve rec zoladex ai from11/2025 after 3 m dp locally rebiopsy triple nnegative rec 14 weeks taxol bs sd sm dp with dp locally nnewly developped skin nodules left breast and axilla for mdt to omit navelbine and maintain xeloda single agent (4+ 3) avoid controloc with xeloda ! antodine instead patient received 3 cycles of xeloda subjective improvement to reduce the dose to 6 cycles daily today ct showed a small HFL 1 CM WAS 8/25 3 CMS NOT SEEN IN 12/25 bs 4/2026 sd .cts 16/6 widespread osseous lesions d8 IS pathological fracture single hfl seg 8 m 1.5x1 not present in cts 12/2025 comp to 12/2025 before st xeloda by 4 months . on exam ulcerative lesions and skin nodules in left breast improved . for pall rth for zoladex today pt is on xeloda			
تحريراً في ,			
		التاريخ :	19-09-2026
		الوقت :	
		حنا عزت شفيق ناودروس	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			

on examination clinical progression of the subcut nodules and the breast mass new ct scan 6/26 new HFL BONE SCAN REQ

patient will receive first cycle of gemzar carbo today after labs

MDT FORM

29/12/2025 G

Name	ب. م. م. م.	MRN	0112802--V7
Age	43	ID	2022/1/20
Menopausal status	on Zoladex	Phone	01190701000
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC-II

ER: 2/2 PR: 2/2 HER 2: 0 Ki67:

Sonomammography:

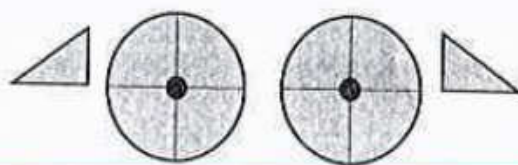
Met Breast Can to Bone.

Mets Workup: recent AXI / Zoladex

with X-ray
with AX

R

L



TNM

Recommendations:

Re AX → type -ve

MDT OUTCOME & PLAN

For further Sol gel - 2/2/25
Pt has heterogenous disease (77 TNBC 8 HR+ Her+)
Discussion of the
in March, start 1st line chemo weekly
TAMU x 9) the reason

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name :	رياب مصطفى محمد عبد المعطي	Request No. :	13008999
Patient No. :	28109260102823	Request Date :	14/09/2025
Path No. :	SR-1268/25	Verification Date :	16/09/2025
Sex :	Male	Financial Category :	جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age :	44 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast UOQ mass.
Nature of Specimen: Referred unstained slides (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:

Four referred unstained slides were received labelled by (10771-25).

Technique:

- Sections were prepared from the unstained slides, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
-H&E, ER clone (1E2), PR clone (SP1) & Her2 clone (4B5).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * DCIS: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 85% of tumor cells (score 8/8).
 - Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).

Diagnosis:

Left breast mass, Referred unstained slides (Tru-cut biopsy):

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 20/09/2025 09:34:07

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / رباب مصطفى محمد عبد المعطي :	Request No. : 13003921
Patient No. : 28109260102823	Request Date : 11/12/2025
Path No. : 3840/25	Verification Date : 15/12/2025
Sex : Female	Financial Category : جوسف روسي - نفقة الدولة
Age : 44 Y	Department : طوارئ
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left axillary lymph node enlargement in known case of left breast cancer.
Nature of specimen: Tru-cut biopsy collected on 11/12/2025, at 11:30 a.m, Cold ischemia time: 10 seconds.

Gross examination:

Three grey white tissue cores ranging in size from 1 cm to 1.5 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: HER2/NEU (4B5), KI67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination:

* Histopathological examination reveals cores of lymphoid tissue widely infiltrated by malignant epithelial cells showing marked nuclear pleomorphism, arranged in clusters & nests with poor tendency to tubular formation.

- IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- GATA3: Positive nuclear staining in tumor cells.
- ER: Negative nuclear staining in tumor cells (Allred score 0/8)
- PR: Negative nuclear staining in tumor cells (Allred score 0/8)
- HER2: Faint incomplete membrane reaction in 3% of tumor cells (Ultra-low, score 0)

Diagnosis

Left axillary lymph node, Tru-cut biopsy:
Metastatic carcinomatous deposits of breast origin.
IPT:

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 22/12/2025 10:15:13

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name : Rabab Moustafa Mohamed Abd Al

Date : 22-12-2025 02:04

Moaty

Branch : Portable

Medical No. : GRI-111589

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- Known case of left breast cancer showed diffuse skin thickening of the left breast with underlying heterognoeus density.
- Multiple left axillary lymph nodes, the largest measures 41 x 23 mm
- Few scattered bilateral pulmonary nodules, the largest is seen in the left lower lobe measuring 9 mm.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Multiple lytic and sclerotic lesions seen scattered along the vertebral bodies, manubrium, both iliac bones and sacrum.

Name : Rabab Moustafa Mohamed Abd Al

Date : 22-12-2025 02:04

Moaty

Branch : Portable

Medical No. : GRI-111589

Ref. Physician Prof :

Ins. Company :

- Reduced vertical height of D8 vertebral body

Opinion:

- ❖ Known case of left breast cancer.
- ❖ Few pulmonary nodules and osseous lesions likely metastatic for follow up.

Dr. Asser Ahmed

Dr. Asser Ahmed

Patient Name: Rabab Moustafa Mohamed Abd Al Moaty	Date : 20/09/2025
Exam : MRI BRAIN WITH CONTRAST	Age : 44 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 111589

HIGH FIELD MRI OF THE BRAIN WITH CONTRAST

Findings:

- No cerebral areas of abnormal signal intensity .
- No abnormally enhancing lesions.
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of deformity or displacement.
- No brain stem areas of abnormal signal intensity
- No mid line shift.
- No extra-axial collections.
- No abnormally enhancing lesions .

OPINION:

No metastatic deposits

Dr. Reham Khedr (MD)

Signature Reeham.Khader
20/09/2025 12:03 PM

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 12/9/2026 Time of delivery: 3:30pm Transfusion start time: 3:30pm End Time: 4:45pm
Blood Group & RH Type: A Type of blood unit: Blood unit No:

Blood unit double checking:	☒ Assigned nurse	Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature: Azza Said 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☒ Assigned nurse	Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025	☒ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature: Azza Said 3012

Nursing Observation: ☒ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: Time: ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☒ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	3pm	38.5	80	99	19	140/80	-
After 5 minutes	3:05pm	38.5	83	98	19	140/80	-
After 10 minutes	3:10pm	38.8	85	99	18	140/90	-
After 15 minutes	3:15pm	38.5	89	98	19	140/90	-
After 30 minutes	3:30pm	37.1	85	97	18	140/95	-
After 45 minutes	3:45pm	37.1	83	98	19	140/89	-
After 60 minutes	4pm	37.1	85	99	17	130/90	-
After 90 minutes	4:30pm	37.1	88	98	18	130/90	-
After completion of transfusion	4:45pm	37	87	99	18	140/90	-
After 5 minutes from completion of transfusion	4:50pm	37.1	88	98	19	140/80	-
After 1 hour from completion of transfusion	5:45pm	37.1	83	99	17	140/80	-
After 2 hours from completion of transfusion	6:45pm	37	87	97	18	140/80	-

Nurse Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025 Date: 12/9/2026 Time: 6:45pm

* Use separate form for each unit transfused.

Blood Delivery form

Blood Delivery form			Order Status	Time of Order
Components	Amount			
Whole blood			L Scheduled	
Packed RBCs	One Unit		L Emergency	
Filtered Packed RBCs			L High Emergency (without cross matching)	
Irradiated Packed RBCs			L	
Fresh Frozen Plasma			L	
Platelet concentrate			L	
Cryo precipitate			L	
Irradiated Platelet			L	

Time of Delivery of Blood

2:54:23 p

Components:

(A)

RH Group (D antigen):

Positive

Blood Group:

Antibody Screening:

Matched

Cross Matching:

Bag No.:

2796

75945141

Duration time

EXPIRATION DATE

1/9/2026

6/10/2026

EXPIRATION DATE

Donation time

EXPIRATION DATE

**Blood Bank Physician
Name & ID**

NYBAA SAYED

Date of Delivery

BAA SAYE

2-542

Assigned Nurse/
Healthcare Assistant
Name & ID

Signature _____

Time

14-2036-سليتيه

2:54 p

1

- * Do NOT use abbreviations.

الرقم الطبي:	2234
اسم المريض:	رنا مصطفى محمد
تاريخ الميلاد:	26/09/1981
الرقم الطبي القديم:	2524/2025

Blood / Blood Components Transfusion Consent

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

أقر أنا الموقع أدناه (المريض / ممثل القانوني) رقم قومي / جواز سفر:
 الرقم الطبي: التشخيص:
 أنا قد وافقت على إعطاء الدم و/أو أحد مشتقاته وذلك بعد أن قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح ومفهوم:

١- سبب الحاجة إلى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالباً ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالباً ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الانتانات أو فشل الكبد.

٢- الفوائد المتوقعة من هذا الإجراء

٣- المخاطر والمضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ- ردود الفعل التحسسية والتي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بأمراض فيروسية وبكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تتفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم إن وجدت:

٥- حتى في طرح الأسئلة والحصول على الإجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

أقر أنا الموقع أدناه بأنني على كامل المعرفة والفهم لكل مشتقات هذا الإقرار واتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما فيه

اسم المريض (أو ممثله القانوني): اسم الطبيب المعالج / الرقم الوظيفي:

درجة القرابة: التوقيع:
 رقم قومي / جواز سفر: التاريخ / الوقت:

التوقيع:
 اسم الشاهد:
 لتاريخ / الوقت:
 رقم قومي / جواز سفر:
 التوقيع:

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 12/9/2026 Time of delivery: 3:30pm Transfusion start time: 3:30pm End Time: 4:45pm
Blood Group & RH Type: A Type of blood unit: Blood unit No:

Blood unit double checking:	☒ Assigned nurse	Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025	☐ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature: Azza Said 3012
Patient Identification double checking (bedside):	☒ Assigned nurse	Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025	☒ Charge Nurse	Name & ID: Azza Said 3012 Signature: Azza Said 3012

Nursing Observation: ☒ No reaction ☐ Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)
If reaction, Notified to: Time: ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☒ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	3pm	36.5	80	99	19	140/80	-
After 5 minutes	3:05pm	36.5	83	98	19	140/80	-
After 10 minutes	3:10pm	36.8	85	99	18	140/90	-
After 15 minutes	3:15pm	36.5	89	98	19	140/90	-
After 30 minutes	3:30pm	37.1	85	97	18	140/95	-
After 45 minutes	3:45pm	37.1	83	98	19	140/89	-
After 60 minutes	4pm	37.1	85	99	17	130/90	-
After 90 minutes	4:30pm	37.1	88	98	18	130/90	-
After completion of transfusion	4:45pm	37	87	99	18	140/90	-
After 5 minutes from completion of transfusion	4:50pm	37.1	88	98	19	140/80	-
After 1 hour from completion of transfusion	5:45pm	37.1	83	99	17	140/80	-
After 2 hours from completion of transfusion	6:45pm	37	87	97	18	140/80	-

Nurse Name & ID: Alaa Khairy 3025 Signature: Alaa Khairy 3025 Date: 12/9/2026 Time: 6:45pm

* Use separate form for each unit transfused.

Blood Delivery form

Patient name:	رياب مصطفى محمد
MRN:	2524/2025

نقطة دولة نقدي

Components		Amount	Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐ Scheduled	
☐	Packed RBCs	One Unit	☐ Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐ High Emergency (without tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs		☐	
☐	Fresh Frozen Plasma		☐	
☐	Platelet concentrate		☐	
☐	Cryo precipitate		☐	
☐	Irradiated Platelet		☐	

Time of Delivery of Blood

Components:

Blood Group:

Antibody Screening:

Cross Matching:

2:54:23 م

(A)

Positive

RH Group (D antigen):

Positive

Matched

Bag No.:

2796

Z5945141

Donation time

1/9/2026

EXPIRATION DATE

6/10/2026

Donation time

EXPIRATION DATE

Blood Bank Physician Name & ID

NYRAA SAYED

Signature

NYRAA SAYED

Date of Delivery

19-2026-سبتمبر

2:54 م

Time

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID

Signature

Date of Delivery

19-2026-سبتمبر

2:54 م

Time

BC

Unit:

Diet Type:

78409

[illegible]

... should be dated, timed, and signed.

* All orders, modified orders,
Do NOT use abbreviations.

*** Do NOT use abbreviations.**
This form is NOT intended for use for medications orders.

الرقم الطبي:	2234
اسم المريض:	رنا مصطفى محمد
تاريخ الميلاد:	26/09/1981
الرقم الطبي القديم:	2524/2025

Blood /Blood Components Transfusion Consent

اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

أقر أنا الموقع أدناه (المريض / ممثل القانوني) رقم قومي / جواز سفر:
 الرقم الطبي: التشخيص:

أني قد وافقت على إعطاء الدم و/أو أحد مشتقاته وذلك بعد أن قام الطبيب بشرح ما يلي بشكل واضح ومفهوم:
 ١- سبب الحاجة إلى نقل الدم في حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالباً ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالباً ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الانتانات أو فشل الكبد.

٢- الفوائد المتوقعة من هذا الإجراء

٣- المخاطر والمضاعفات المحتملة بما في ذلك:

أ- ردود الفعل التحسسية والتي قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بأمراض فيروسية وبكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم إن وجدت:

٥- حتى في طرح الأسئلة والحصول على الإجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

أقر أنا الموقع أدناه بأنني على كامل المعرفة والفهم لكل مشتقات هذا الإقرار وتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما فيه
 اسم المريض (أو ممثله القانوني): اسم الطبيب المعالج / الرقم الوظيفي:

درجة القرابة: التوقيع:

رقم قومي / جواز سفر: التاريخ / الوقت:

التوقيع:

اسم الشاهد:

لتاريخ / الوقت:

رقم قومي / جواز سفر:

توقيع: